ENDOCRINO: TIROIDES, PARATIROIDES Y SUPRARRENALES

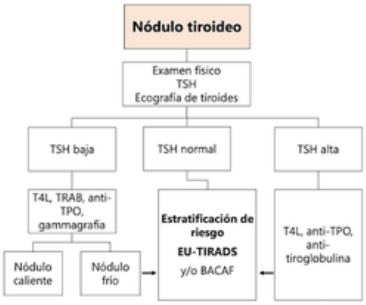
DR. ALFREDO MATOS

GLÁNDULA TIROIDES: FUNCIÓN Y PATOLOGÍAS

- Función: produce T3/T4, regula el metabolismo, crecimiento y desarrollo.
- Nódulos tiroideos: benignos o malignos; tto. tiroidectomía parcial o total.
- Cáncer de tiroides: papilar, folicular, medular y anaplásico; tiroidectomía total + disección ganglionar.
- Bocio multinodular y enfermedad de Graves (hipertiroidismo resistente a tratamiento médico): tiroidectomía subtotal o total.

NÓDULO TIROIDEO: EVALUACIÓN

- Evaluación inicial: ultrasonido cervical y TSH; biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF) si hay características sospechosas (hipoecogenicidad, bordes irregulares, microcalcificaciones).
- Sistema Bethesda: clasifica el resultado citológico y orienta la conducta (observación, repetir BAAF o cirugía).



POSTOPERATORIO DE TIROIDES

- Reposición hormonal con hormona tiroidea tras tiroidectomía total.
- Monitorización del calcio: riesgo de hipocalcemia transitoria o permanente si se lesionan las paratiroides.

TIROIDECTOMÍA: COMPLICACIONES ESPECÍFICAS

- Lesión del nervio laríngeo recurrente: disfonía o afonía; lesión del nervio laríngeo superior: cambios en el tono de voz.
- Hematoma cervical postoperatorio: puede comprometer la vía aérea; emergencia quirúrgica que requiere evacuación inmediata.

GLÁNDULAS PARATIROIDES

- 4 glándulas detrás de la tiroides; producen PTH, que regula calcio y fósforo.
- Hiperparatiroidismo primario (adenoma): paratiroidectomía para remover el adenoma.
- Hiperparatiroidismo secundario/terciario (ERC o postrasplante renal): paratiroidectomía subtotal o total con autoimplante.
- Postoperatorio: riesgo de hipocalcemia; suplementación con calcio y vitamina D.

PARATIROIDES: LOCALIZACIÓN PREOPERATORIA

- Gammagrafía con sestamibi y ultrasonido cervical para localizar el adenoma antes de la cirugía.
- PTH intraoperatoria: su caída >50% tras la resección confirma el éxito quirúrgico.

GLÁNDULAS SUPRARRENALES

- 2 glándulas sobre cada riñón: corteza (cortisol, aldosterona, hormonas sexuales) y médula (adrenalina, noradrenalina).
- Feocromocitoma: exceso de catecolaminas; adrenalectomía.
- Síndrome de Conn (hiperaldosteronismo) y síndrome de Cushing: adrenalectomía del adenoma productor.
- Carcinoma suprarrenal: adrenalectomía radical + quimio/radioterapia.

TUMORES SUPRARRENALES: ABORDAJE QUIRÚRGICO

- Adrenalectomía laparoscópica: estándar de oro para la mayoría de los tumores suprarrenales benignos y pequeños.
- Adrenalectomía abierta: reservada para tumores grandes, sospecha de malignidad o invasión local.